ICS 11.020
CCS C 05

DB22

吉 林 省 地 方 标 准

DB 22/T 3227—2021

紧张型头痛中医诊疗技术规范

Technical specification for diagnosis and treatment of tension-type headache

2021－04－16 发布　　2021－05－01 实施

吉林省市场监督管理厅　　发 布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由吉林省中医药科学院提出。

本文件由吉林省中医药管理局归口。

本文件起草单位：吉林省中医药科学院，长春市中医院，北华大学附属医院，吉林省脑科医院，辽源市中医院。

本文件主要起草人：孙莉、陈心智、王彦红、艾春玲、姜立刚、辛丽华、李帅、郝云、刘寅、项颖。

紧张型头痛中医诊疗技术规范

1 范围

本文件规定了紧张型头痛的诊断、辨证论治、其他疗法、预防调护和注意事项。

本文件适用于紧张型头痛的中医诊断和治疗。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 诊断

4.1 中医证候

4.1.1 肝阳上亢证

头痛，头晕，失眠，心烦急躁，面红耳赤，口苦眼干，舌红苔黄，脉弦。

4.1.2 瘀血阻络证

头痛经久不愈，痛处固定不移，痛如锥刺，或有头部外伤史，舌质暗，或有瘀斑、斑点，苔薄白，脉细或细涩。

4.1.3 痰浊上扰证

头痛且头重昏蒙，胸脘痞闷，呕吐痰涎，恶心纳差，苔白腻，脉滑。

4.1.4 气血亏虚证

头痛隐隐，或伴头晕，心悸不宁，面色少华，神疲乏力，遇劳加重，休息减轻，舌质淡，苔薄白，脉细弱。

4.1.5 肝郁气滞证

头痛于一侧，或牵至眉棱骨及后颈部，心烦易怒，胸胁胀痛，舌微紫，脉弦。

4.1.6 肝肾阴虚证

头痛且空，眩晕耳鸣，腰膝酸软，舌红少苔，脉弦细或细数。

4.2 西医诊断

4.2.1 偶发性紧张型头痛诊断

4.2.1.1 平均每月发作＜ 1 d（每年＜ 12 d），至少发作 10 次以上并符合诊断标准 4.2.1.2～4.2.1.4。

4.2.1.2 头痛持续 30 min 到 7 d。

4.2.1.3 头痛至少符合下列 4 项中的 2 项：

a) 双侧头痛；
b) 性质为压迫性或紧箍样（非搏动性）；
c) 轻或中度头痛；
d) 日常活动如走路或爬楼梯不加重头痛。

4.2.1.4 符合下列全部 2 项：

a) 无恶心或呕吐；
b) 畏光、畏声中不超过 1 项。

4.2.1.5 不能用 ICHD-3 中的其它诊断更好地解释。

4.2.2 频发性紧张型头痛诊断

4.2.2.1 平均每月发作 1 d～14 d 超过 3 个月（每年≥ 12 d 且＜ 180 d），至少发作 10 次以上并符合诊断标准 4.2.2.2～4.2.2.4。

4.2.2.2 头痛持续 30 min 至 7 d。

4.2.2.3 头痛至少符合下列 4 项中的 2 项：

a) 双侧头痛；
b) 性质为压迫性或紧箍样（非搏动性）；
c) 轻或中度头痛；
d) 日常活动如走路或爬楼梯不加重头痛。

4.2.2.4 符合下列全部 2 项：

a) 无恶心或呕吐；
b) 畏光、畏声中不超过 1 项。

4.2.2.5 不能用 ICHD-3 中的其他诊断更好地解释。

4.2.3 慢性紧张型头痛诊断

4.2.3.1 头痛平均每月发作时间≥ 15 d，持续超过 3 个月（每年≥ 180 d），并符合诊断标准 4.2.3.2～4.2.3.4。

4.2.3.2 头痛持续数小时至数天或持续性。

4.2.3.3 头痛至少符合下列 4 项中的 2 项：

a) 双侧头痛；
b) 性质为压迫性或紧箍样（非搏动性）；
c) 轻或中度头痛；
d) 日常活动如走路或爬楼梯不加重头痛。

4.2.3.4 符合下列全部 2 项：

a) 畏光、畏声和轻度恶心 3 项中最多只有 1 项；
b) 既无中、重度恶心，也无呕吐。

4.2.3.5 不能用 ICHD-3 中的其他诊断更好地解释。

4.2.4 很可能的紧张型头痛诊断

4.2.4.1 很可能的偶发性紧张型头痛：

a) 1 次或多次头痛发作符合 4.2.1 偶发性紧张型头痛 4.2.1.1～4.2.1.4 中除 1 项外的全部；

b) 不符合 ICHD-3 里其他类型头痛的诊断标准；

c) 不能用 ICHD-3 中的其他诊断更好地解释。

4.2.4.2 很可能的频发性紧张型头痛：

a) 头痛发作符合 4.2.2 频发性紧张型头痛 4.2.2.1～4.2.2.4 中除 1 项外的全部；

b) 不符合 ICHD-3 里其他类型头痛的诊断标准；

c) 不能用 ICHD-3 中的其他诊断更好地解释。

4.2.4.3 很可能的慢性紧张型头痛：

a) 头痛发作符合 4.2.3 慢性紧张型头痛 4.2.3.1～4.2.3.4 中除 1 项外的全部；

b) 不符合 ICHD-3 里其他类型头痛的诊断标准；

c) 不能用 ICHD-3 中的其他诊断更好地解释。

5 辨证论治

5.1 肝阳上亢证

5.1.1 治法

平肝潜阳。

5.1.2 方药

参见附录 A.1。

5.1.3 加减

头痛剧烈、目赤口苦，便秘尿黄者，加夏枯草、龙胆草、大黄。

5.2 瘀血阻络证

5.2.1 治法

活血化瘀，通络止痛。

5.2.2 方药

参见附录 A.2。

5.2.3 加减

久病气血不足者，加黄芪、党参；头痛较剧，久痛不已者，加全蝎、蜈蚣。

5.3 痰浊上扰证

5.3.1 治法

燥湿化痰。

5.3.2 方药

参见附录 A.3。

5.3.3 加减

脾虚明显，加党参、炒白扁豆、薏苡仁；口苦便秘，舌红苔黄腻，脉滑数者，加黄芩、竹茹、枳实、胆南星；胸闷，呕恶明显，加厚朴、枳壳。

5.4 气血亏虚证

5.4.1 治法

气血双补。

5.4.2 方药

参见附录 A.4。

5.4.3 加减

神疲乏力明显，遇劳加重，汗出气短，畏风怕冷者，加黄芪、细辛；因肝肾亏虚而见耳鸣、虚烦、少寐，加制何首乌、女贞子、枸杞子、炒酸枣仁。

5.5 肝郁气滞证

5.5.1 治法

疏肝解郁。

5.5.2 方药

参见附录 A.5。

5.5.3 加减

烦躁易怒，少寐多梦加龙胆草、郁金、夜交藤；头晕，乏力，失眠多梦，短气健忘，面色微黄加熟地黄、何首乌、党参、茯神；头痛较甚，病程较久加全蝎或蜈蚣。

5.6 肝肾阴虚证

5.6.1 治法

养阴补肾，填精益髓。

5.6.2 方药

参见附录 A.6。

5.6.3 加减

疼痛明显者加全蝎、蜈蚣。

6 其他疗法

6.1 针刺

6.1.1 取穴：选取百会、风池、率谷、角孙、太阳、列缺、合谷、太冲。

6.1.2 每次留针 30 min，每天 1 次。
6.1.3 针刺 1 周为 1 个疗程，连续治疗 4 个疗程。
6.1.4 皮肤感染、溃疡或肿瘤部位，不宜针刺，有出血倾向者，慎行针刺。

6.2 推拿

6.2.1 患者取坐位，术者先用滚法或推法施于两侧肩部和颈部肌肉及局部阿是穴，以放松该部位肌肉。再根据患者病情施以局部推拿。
6.2.2 眼眶疼痛：患者仰卧位，术者以食指或食中指交叠点揉印堂、睛明、攒竹、太阳各 30 s，双手拇指指腹呈八字状，自两侧睛明沿眉弓分推至两侧瞳子髎 30 次，自印堂向上至发际推 30 次。
6.2.3 全头痛：患者仰卧位，术者先用食指或拇指点揉头维、率谷、百会、四神聪各 30 s，用五指沿头部五经采用拿法 10 次；用喙法作用于头顶部 30 次。
6.2.4 偏侧头痛：患者仰卧位，术者以一指禅推法于头维穴施治 1 min，再于头侧沿手足少阳经循行路线逆时针进行一指禅推拿，约 2 min，反复操作 10 次。
6.2.5 颈项部疼痛：患者坐位，术者以一指禅作用于颈部正中督脉及两侧膀胱经，各经自上而下各 3 次～ 5 次；施滚法于颈肩部 5 min；拿揉风池、风府、阿是穴及条索状肌筋结节各 30 s，最后提拿双侧肩井 3 次～5 次。
6.2.6 推拿隔天 1 次，15 次为 1 个疗程。
6.2.7 皮肤感染、溃疡、骨质疏松及有出血倾向者禁用。

6.3 穴位注射

6.3.1 取穴：双侧风池、翳风、百会、率谷、头维。
6.3.2 取 2% 利多卡因 2 ml、地塞米松磷酸钠注射液 1 ml、维生素 B_1 100 mg 和维生素 B_{12} 500 μg，配制药液 5 ml。
6.3.3 常规消毒穴位局部皮肤，取百会、率谷、头维穴，针头向下与皮肤呈 45° 刺入穴位深层，直达颅骨骨膜下，取风池穴，针尖向对侧眼眶内下方进针 2.0 cm～2.5 cm，取翳风穴，针尖向对侧乳突方向深刺 2.5 cm～3.0 cm，得气有酸胀感，回抽无血液后，每穴注入药液 0.5 ml。
6.3.4 3 d 注射 1 次，不宜超过 10 次。
6.3.5 对上述成分过敏者禁用。

6.4 耳穴压豆法

6.4.1 取穴：选取神门、心、肝、肾、脾。
6.4.2 将耳穴贴贴于所选的穴位 2 个～3 个，轻轻按压 3 min。
6.4.3 每日按压 3 次～5 次，2 d～3 d 更换 1 次。两耳交替进行。
6.4.4 患者出现头痛可随时按压，至头痛缓解为止，2 周为 1 个疗程。
6.4.5 耳廓有炎症、冻伤禁用。

7 预防调护

7.1 饮食

7.1.1 饮食有节，定时定量，少食多餐，宜清淡，避免肥甘厚味。

7.1.2　肝阳上亢者，可服银耳汤、冬瓜、黄瓜、萝卜等。痰浊中阻者，可服冬瓜、薏苡仁、山楂、鲤鱼等。血虚阴亏者，可服鸡肉、狗肉、红枣、蘑菇、白木耳等。中气虚弱者，可服核桃、百合、黑芝麻、猪腰等。

7.1.3　降低咖啡因的摄入。

7.2　起居

7.2.1　床铺应清洁干燥、平软。

7.2.2　居住环境宜安静整洁，空气流通，光线柔和或偏暗，温度、湿度适宜。

7.2.3　多休息，作息规律，避免过度劳累、经常熬夜等。

7.2.4　减少陪护及探视，避免外界不良刺激。

7.3　情志

7.3.1　做好情志疏导工作，避免暴怒和郁闷不乐，以免加重头痛。

7.3.2　紧张型头痛发作时要设法分散患者的注意力，指导患者通过转移法、释放法等进行自我调控，放松紧张情绪，缓解其压力。

8　疗效评价

8.1　总体治疗效果评判

8.1.1　临床痊愈：疼痛停止，随访 1 个月无复发；

8.1.2　显效：疼痛停止后， 1 个月内复发，但积分较治疗前减少 50% 以上；

8.1.3　有效：头痛积分较前减少 21%～50% ；

8.1.4　无效：头痛积分较前减少小于 20% ；

8.1.5　计算法：总有效率可按公式（1）计算：

$$\alpha = \frac{\beta_1 + \beta_2 + \beta_3}{\gamma} \times 100\% \quad \cdots\cdots (1)$$

式中：β_1——痊愈例数。

β_2——显效例数。

β_3——有效例数。

γ——总例数。

8.2　头痛程度评价

视觉模拟评分法（VAS）进行疼痛等级评价，确定头痛程度；

8.3　心理状态评估

应用汉密尔顿焦虑量表和汉密尔顿抑郁量表对治疗前后心理状态进行评价。

附　录　A
（资料性）
治疗方药

A.1　肝阳上亢证

天麻钩藤饮：天麻 15 g、钩藤 15 g、石决明 20 g、川牛膝 15 g、益母草 15 g、黄芩 10 g、栀子 9 g、杜仲 15 g、桑寄生 15 g、夜交藤 15 g、茯苓 15 g。

A.2　瘀血阻络证

通窍活血汤：川芎 15 g、赤芍 15 g、桃仁 10 g、红花 15 g、益母草 15 g、大枣 9 g。

A.3　痰浊上扰证

半夏白术天麻汤：半夏 15 g、白术 15 g、天麻 15 g、茯苓 15 g、生姜 6 g、橘红 10 g、大枣 9 g、甘草 6 g。

A.4　气血亏虚证

八珍汤：白芍 30 g、当归 15 g、熟地黄 30 g、川芎 15 g、党参 20 g、茯苓 15 g、白术 15 g、甘草 10 g。

A.5　肝郁气滞证

柴胡疏肝散：柴胡 15 g、川芎 15 g、白芍 15 g、香附 9 g、枳壳 6 g、陈皮 6 g。

A.6　肝肾阴虚证

六味地黄丸：熟地黄 20 g、山茱萸 20 g、山药 18 g、泽泻 12 g、牡丹皮 12 g、茯苓 20 g。